UE B.1 • S1 • PARTIE 1

Douleur : bases anatomophysiologiques, physiopathologiques et psychologiques

Cours détaillé • Comprendre • synthèse du support Moodle

1. Comprendre ce que l’on appelle douleur

Définition IASP (2020)

Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à, ou ressemblant à celle associée à, une lésion tissulaire réelle ou potentielle.

Cette définition rappelle que la douleur est une expérience personnelle. La parole de la personne est à respecter, même si l’examen ou l’imagerie ne montre pas de lésion proportionnelle. Une incapacité à communiquer verbalement n’exclut pas la douleur : observation et outil adapté sont alors nécessaires.

Trois notions à distinguer

Nociception : activité nerveuse de détection et de traitement d’un stimulus potentiellement dangereux. Elle n’est pas, à elle seule, la douleur ressentie.
Douleur : expérience vécue, influencée par le corps, les émotions, les pensées et le contexte.
Souffrance : retentissement plus global, pouvant toucher le psychisme, les relations, les activités et le sens donné à la situation.

Les quatre dimensions

Sensorielle-discriminative : localisation, intensité, durée, qualité. Affective-émotionnelle : caractère pénible, peur ou anxiété. Cognitive : croyances, attention, mémoire et interprétation. Comportementale : protection, retrait, immobilité, mimiques ou verbalisation.

Repère de soin

Deux personnes ayant une lésion comparable peuvent vivre des douleurs différentes. L’écart ne prouve ni simulation ni exagération.

Douleur : bases anatomophysiologiques, physiopathologiques et psychologiques

Cours détaillé • Comprendre • synthèse du support Moodle

2. Modèle biopsychosocial

La douleur se comprend par l'interaction de facteurs biologiques (atteinte, inflammation, système nerveux, sommeil), psychologiques (émotions, attentes, attention, expériences antérieures) et sociaux (entourage, travail, culture, environnement, relation de soin). Aucun de ces facteurs ne rend la douleur « imaginaire ».

Exemple : après une blessure, la douleur peut persister alors que les tissus guérissent. La peur du mouvement, le manque de sommeil, le stress et l'isolement peuvent contribuer au retentissement; ils ne signifient pas que la personne choisit d'avoir mal.

Trajet du message nociceptif

Transduction : un stimulus mécanique, thermique ou chimique est converti en activité électrique par les terminaisons nerveuses. Transmission : le signal circule dans les fibres nerveuses vers la moelle puis les voies cérébrales. Modulation : le signal peut être amplifié ou freiné à différents niveaux. Perception : le cerveau intègre le message avec l'attention, les émotions, les souvenirs et le contexte.

À retenir

Le cerveau participe à l'expérience douloureuse; cela ne veut pas dire que la douleur est « dans la tête ». Le vécu est réel, même quand la lésion n'est pas visible.

Nocicepteurs : détectent un stimulus nocif ou potentiellement dangereux. Ils ne « ressentent » pas seuls l'expérience consciente de douleur.

Douleur : bases anatomophysiologiques, physiopathologiques et psychologiques

Cours détaillé • Comprendre • synthèse du support Moodle

3. Mécanismes et temporalité

Douleur nociceptive : liée à l'activation du système nociceptif par une atteinte ou inflammation des tissus. Neuropathique : liée à une lésion ou maladie du système somatosensoriel; descriptions possibles : brûlure, décharges, fourmillements, engourdissement. Nociplastique : liée à une nociception altérée, sans preuve claire qu'une lésion tissulaire ou une lésion du système somatosensoriel explique à elle seule la douleur. Des mécanismes peuvent coexister.

Ces catégories orientent le raisonnement; elles ne se déduisent pas d'un seul mot ni ne remplacent une évaluation médicale.

Aiguë et chronique

La douleur aiguë est généralement récente et peut jouer un rôle de signal d'alarme. La douleur chronique persiste ou récidive au-delà de trois mois; elle peut avoir un retentissement propre sur le fonctionnement et la qualité de vie. Elle mérite une évaluation globale et régulière.

Attention au raccourci

Absence de lésion visible ≠ absence de douleur. Une douleur chronique ≠ douleur forcément permanente ou identique chaque jour.

Ce que l'IDE observe et transmet

Localisation et irradiation; début, durée et évolution; qualité décrite avec les mots du patient; intensité avec une échelle adaptée; facteurs qui aggravent ou soulagent; sommeil, humeur, mobilité et activités; traitements reçus et effets indésirables observés; attentes et priorités de la personne.

Transmission utile

Décrire les faits et les propos (« brûlure au mollet depuis… », score selon outil, retentissement), l'action réalisée selon prescription/protocole, puis la réévaluation. Éviter les jugements (« exagère », « psychologique »).

Douleur : bases anatomophysiologiques, physiopathologiques et psychologiques

Cours détaillé • Comprendre • synthèse du support Moodle

4. Posture IDE et entraînement

Écouter et croire le vécu : accueillir la plainte sans minimiser; demander ce qui gêne le plus et ce que la personne souhaite pouvoir refaire. Évaluer : autoévaluation si possible avec l'outil du service; sinon hétéroévaluation adaptée et observation répétée. Agir : appliquer prescription et protocoles, installer/conforter selon la situation, informer l'équipe, puis réévaluer l'effet et les éventuels effets indésirables.

Limites de rôle

L'IDE recueille, évalue, met en œuvre les soins relevant de son rôle et transmet. Le choix d'un diagnostic ou d'un traitement relève du professionnel habilité; se référer aux prescriptions, protocoles locaux et encadrement.

Mini-quiz : répondre avant de lire le corrigé

1. Une personne dit avoir mal mais l'imagerie est rassurante : que retenir ?
2. Les nocicepteurs ressentent-ils la douleur consciente ?
3. Citez les quatre dimensions de la douleur.
4. Une douleur chronique signifie-t-elle que la personne simule ?
5. Que faut-il faire après une action de soulagement ?

Corrigé

1. Respecter le vécu et poursuivre l'évaluation. 2. Non, ils détectent des stimuli nocifs; la douleur est une expérience intégrée. 3. Sensorielle, affective, cognitive, comportementale. 4. Non. 5. Réévaluer, tracer et transmettre selon le cadre du soin.

Sources : cours Moodle « Douleurs partie 1 bases »; IASP, définition et notes explicatives (2020), iasp-pain.org; Ministère chargé de la Santé, « La douleur : de quoi parle-t-on ? » (2024), sante.gouv.fr.